

TEMA 7.1 • PSIQUIATRÍA GENERAL

Psiquiatría Infantil: Trastorno del Espectro Autista

PERFIL EUNACOM 4.01.1.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Introducción al Trastorno del Espectro Autista (TEA)

El **Trastorno del Espectro Autista (TEA)**, anteriormente clasificado bajo el término ahora obsoleto de "Trastornos Generalizados del Desarrollo", representa una de las áreas más críticas de la psiquiatría infantil. Su importancia radica en que un diagnóstico oportuno y una intervención temprana cambian radicalmente el pronóstico y la calidad de vida no solo del niño, sino de todo su entorno familiar.

Actualmente, el TEA no se considera una "enfermedad" en el sentido tradicional, sino una **condición** que forma parte de la **neurodiversidad**. Esto implica que el cerebro procesa la información y se comunica de una manera distinta a la de las personas neurotípicas.

Etiología y Epidemiología

La causa exacta del TEA aún es desconocida. Sin embargo, existe un fuerte componente de **agregación familiar**, lo que sugiere una base genética importante: - Existe un riesgo significativamente mayor de TEA en hermanos de niños ya diagnosticados. - No obstante, un porcentaje considerable de casos ocurre de forma esporádica, sin antecedentes familiares directos. - **Prevalencia:** Se estima cercana al **1% de la población general**, aunque algunos estudios sugieren cifras superiores debido a la mejor identificación de rasgos dentro del espectro.

Pilares Clínicos del TEA

El TEA se manifiesta a través de un amplio abanico de síntomas que varían en intensidad. Los tres pilares fundamentales son:

1. Rigidez Cognitiva

Es la falta de flexibilidad en el pensamiento. Se manifiesta como: - **Dificultad en las transiciones:** Resistencia intensa al pasar de una actividad a otra, lo que puede desencadenar rabietas o conductas disruptivas. - **Necesidad de rutinas:** Los rituales y las agendas predecibles disminuyen su estrés. - **Ideas fijas:** Persistencia en conceptos o formas de hacer las cosas, mostrando gran resistencia al cambio.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

La rigidez cognitiva a menudo se confunde con el **Trastorno Oposicionista Desafiante**. Mientras que en el oposicionismo hay una intención de desafiar la autoridad, en el TEA la conducta se debe a la incapacidad neurobiológica de procesar el cambio de actividad.

2. Intereses Restringidos

Se refiere a la focalización intensa en temas específicos que pueden absorber gran parte del tiempo del niño. - **Temas comunes:** Dinosaurios, números, rutas de transporte, series de televisión, ciencia o política. - **Funcionalidad:** Estos intereses pueden ser funcionales (usarlos para aprender otras habilidades) o disfuncionales (cuando lo aíslan totalmente del entorno).

3. Dificultades en la Socialización y Comunicación

Es el área que más impacta en el desarrollo a largo plazo. - **Contacto visual:** Puede estar ausente, ser breve o "pobre" en expresividad. A veces fijan la mirada en la boca en lugar de los ojos. - **Lenguaje literal:** Dificultad para comprender el lenguaje implícito, bromas, sarcasmo o dobles sentidos. - **Atención conjunta:** Incapacidad para compartir el interés por un objeto con otra persona (falla en la "mirada de tres puntos": objeto-persona-objeto). - **Aislamiento:** Algunos niños no tienen interés social,

mientras que otros sí lo tienen pero carecen de las herramientas para concretarlo, lo que genera frustración.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

La **atención conjunta** es un marcador clínico precoz de alta sospecha. Si un niño de 18 meses no señala para compartir interés o no alterna la mirada entre un juguete y el adulto, debe evaluarse formalmente para TEA.

Alteraciones Sensoriales y Motoras

Muchos niños con TEA presentan una forma distinta de procesar los estímulos del entorno: - **Hipersensibilidad:** Ruidos fuertes, texturas de ropa o consistencias de alimentos (selectividad alimentaria) pueden ser insoportables. - **Marcha en punta de pies:** Es frecuente y debe llamar la atención si persiste después de los 2 o 3 años. - **Estereotipias (Manierismos):** Movimientos repetitivos sin fin funcional que sirven para autorregular la ansiedad o expresar alegría. Ejemplos clásicos: **aleteo de manos (flapping)**, abrir y cerrar manos, cruzar dedos o balanceo.

Clasificación y Pronóstico

Aunque el DSM-5 unificó los diagnósticos, en la práctica clínica se siguen diferenciando ciertos perfiles:

TABLA 7.1.1: PERFIL VS LENGUAJE

PERFIL	LENGUAJE	INTELIGENCIA	INTERACCIÓN SOCIAL
Antiguo Asperger	Conservado (puede ser "pedante")	Normal o Superior	Deseo de interactuar, pero sin éxito
TEA Severo (Autismo clásico)	Retraso significativo o ausente	Riesgo de Discapacidad Intelectual	Aislamiento marcado, desconexión

NOTA CLÍNICA

La inteligencia en el TEA suele ser normal. Muchos destacan en áreas específicas debido a su hiperfoco. El pronóstico depende principalmente de dos factores: el nivel de **lenguaje** alcanzado y el **coeficiente intelectual**.

Diagnóstico y Screening

El diagnóstico es **estrictamente clínico** y evolutivo. No se basa en una sola observación, sino en el seguimiento del desarrollo.

- **Screening (Tamizaje):** Se recomienda aplicar el **M-CHAT** a todos los niños entre los 18 y 24 meses en controles de niño sano.
- **Evaluación Estandarizada:** Ante la sospecha (por M-CHAT alterado o sospecha clínica), se derivar para aplicar instrumentos como el **ADOS** o el **ADI-R**.
- **Equipo Multidisciplinario:** Participan psiquiatras infantiles, neurólogos, psicólogos y terapeutas ocupacionales.

Manejo y Tratamiento

No existe una "cura", ya que es una condición del desarrollo, pero la intervención temprana hace "milagros" en la funcionalidad.

- **Educación a los padres:** Es el pilar fundamental. Deben aprender a estimular áreas de comunicación social y flexibilidad en lugar de solo enfocarse en lo académico.
- **Terapia Ocupacional (TO):** Fundamental para el manejo de la integración sensorial y la autonomía.

- **Habilidades Sociales:** Terapias grupales para aprender códigos no verbales y lenguaje implícito.
- **Apoyo Escolar:** Prevención activa del bullying y adaptaciones curriculares si es necesario.
- **Farmacoterapia:** No trata el TEA per se, sino las comorbilidades como la irritabilidad, el **Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad** (TDAH) o la ansiedad.

EUNACOM CRITERIOS

El diagnóstico de TEA nunca es "tarde", pero mientras antes se inicie la estimulación (idealmente antes de los 3 años), mayor es la plasticidad neuronal para compensar las dificultades sociales y comunicativas.

Casos Clínicos Tipo EUNACOM

- **Caso 1:** Niño de 2 años con **retraso del lenguaje** (20 palabras), juego solitario y repetitivo, y marcha en punta de pies. **Sospecha:** TEA. - **Caso 2:** Escolar con excelente rendimiento académico, lenguaje muy formal ("pedante"), obsesión con los helicópteros y dificultades para hacer amigos por no entender las bromas. **Sospecha:** Perfil Asperger (TEA nivel 1). - **Caso 3:** Adulto joven brillante en programación pero incapaz de mantener un trabajo por "falta de sentido común" en la oficina y nula red social. **Sospecha:** TEA no diagnosticado en la infancia.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Madre consulta por su hijo de 2 años que dice solo 15 palabras, no arma frases, juega siempre con el mismo juguete de manera repetitiva, camina en punta de pie y se angustia cuando hay ruido ambiental intenso. No mantiene contacto visual. ¿Cuál es la conducta más adecuada?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Psiquiatría Infantil: Trastorno del Espectro Autista. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El TEA se diagnostica clínicamente con pruebas estandarizadas; el M-CHAT es el screening recomendado desde los 18 meses.
- Los tres ejes clínicos del TEA son: rigidez cognitiva, intereses restringidos y dificultades en la socialización.
- La marcha en punta de pie es normal hasta los 3 años; después de esa edad obliga a evaluar TEA u otras causas.
- Las estereotipias como el aleteo (movimientos de manos) son manierismos que disipan ansiedad y son característicos del TEA.
- El cannabis y en particular la marihuana en personas con predisposición genética pueden duplicar o triplicar el riesgo de desarrollar esquizofrenia.
- El síndrome de Asperger (TEA leve) conserva el lenguaje pero presenta dificultades sociales marcadas; es parte del espectro.
- La intervención temprana a los 18-24 meses genera mejoras radicales en el pronóstico funcional y social del niño con TEA.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (PSIQUIATRÍA INFANTIL: TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA)**PREGUNTA 1**

Madre consulta por su hijo de 2 años que dice solo 15 palabras, no arma frases, juega siempre con el mismo juguete de manera repetitiva, camina en punta de pie y se angustia cuando hay ruido ambiental intenso. No mantiene contacto visual. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A)** Tranquilizar a la madre y reevaluar a los 4 años
- B)** Solicitar RNM cerebral para descartar patología orgánica
- C)** Aplicar screening M-CHAT y derivar a evaluación estandarizada de desarrollo para intervención temprana
- D)** Iniciar metilfenidato para el trastorno por déficit atencional
- E)** Derivar a fonoaudiología solamente para estimulación del lenguaje

PREGUNTA 2

Niño de 8 años con excelentes habilidades en matemáticas y computación pero con dificultades importantes en el juego con pares y en seguir instrucciones implícitas. Su lenguaje es muy formal y pedante para su edad. No presenta retraso mental. Sus padres refieren que desde pequeño tiene un interés obsesivo en los sistemas de transporte. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Trastorno por déficit atencional tipo hipoactivo
- B)** Trastorno del espectro autista (síndrome de Asperger)
- C)** Trastorno de personalidad esquizoide
- D)** Superdotación intelectual sin patología asociada
- E)** Trastorno oposicionista desafiante

PREGUNTA 3

Mujer de 35 años es derivada a psiquiatría por dificultades laborales. Refiere que le cuesta adaptarse a cambios de rutina, tiene un interés muy focalizado en los ecosistemas marinos que ocupa la mayor parte de su tiempo libre, y sus compañeros la describen como "muy literal" y con poca habilidad para leer situaciones sociales. No tiene diagnóstico previo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A)** Iniciar antidepresivos ISRS por probable trastorno depresivo mayor
- B)** Diagnóstico de trastorno de personalidad esquizoide y psicoterapia
- C)** Evaluación diagnóstica de TEA en adultos con intervención psicoeducativa
- D)** Derivar a neurología por posible trastorno neurológico subyacente
- E)** Diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo y ISRS

RESUMEN: PSIQUIATRÍA INFANTIL: TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una condición del neurodesarrollo con componente genético importante, con prevalencia cercana al 1% de la población. No se considera una enfermedad sino parte de la neurodiversidad. Su diagnóstico oportuno y la intervención temprana son fundamentales para cambiar el pronóstico, ya que los niños con TEA requieren una estimulación diferente a la de los niños neurotípicos. La clínica se organiza en tres ejes principales: rigidez cognitiva (dificultad para transitar entre actividades, tendencia a rituales y rutinas), intereses restringidos (focalización intensa en un tema acotado que puede limitar la interacción social) y dificultades en la socialización (disminución del contacto visual, dificultad para leer el lenguaje no verbal e implícito, literalidad en la comunicación). Adicionalmente, son muy frecuentes las alteraciones sensoriales como hipersensibilidad al ruido o a texturas, la marcha en punta de pie (normal hasta los 3 años) y los manierismos y estereotipias como el aleteo. La atención conjunta, capacidad de compartir el foco atencional con otra persona, suele estar alterada y es un marcador clínico importante. El diagnóstico es absolutamente clínico y evolutivo, apoyado en pruebas estandarizadas de desarrollo. La herramienta de screening más recomendada es el M-CHAT, aplicable desde los 18 meses. El espectro incluye desde el antiguo síndrome de Asperger (lenguaje conservado, dificultades sociales) hasta el autismo clásico con retraso de lenguaje significativo. El coeficiente intelectual es variable: la mayoría tiene inteligencia normal y algunos presentan áreas de habilidades destacadas relacionadas con sus intereses restringidos. En casos severos sin intervención puede haber compromiso cognitivo secundario. El manejo del TEA es multidisciplinario, sistémico e incluye educación a los padres como pilar fundamental. La terapia ocupacional trabaja habilidades específicas según las dificultades individuales de cada niño. Es esencial la prevención activa del bullying y la integración en ambientes educativos que comprendan la condición. No existe farmacoterapia específica para el TEA en sí mismo. La intervención temprana, idealmente antes de los 2 años, mejora drásticamente el pronóstico. La analogía del niño sordo con audífonos ilustra el principio: entregar las herramientas adecuadas permite un desarrollo pleno.